

التميّز التشغيلي · من الدراسات العلمية

حين وحّدت المستشفيات طريقة تسليم المرضى بين المناوبات، تحسّن التسليم نفسه.

أما النتائج فتفاوتت من دراسة إلى أخرى.

هذا ما تقوله أربع دراسات حديثة نُشرت بين عامي 2023 و2026.

← اسحب للمتابعة

ماذا يحدث حين تنتهي المناوبة؟

يسلّم الطبيب زميله القادم ما يعرفه عن كل مريض: حالته، وما ينتظره من فحوص، وما يجب فعله إن ساءت حالته.

والأخطاء في هذا التسليم من الأسباب الرئيسة للأخطاء الطبية. لذلك تعلّم الأطباء المقيمون في 32 مستشفى أمريكيًا طريقة موحّدة للتسليم، ورافقتهم فرق تدريب 18 شهرًا.

تُسمّى الطريقة (I-PASS)، ولها خمس خطوات: شدة حالة المريض، وملخص حالته، وقائمة المهام، وما قد يحدث وكيف يُتصرَّف إن حدث، ثم يلخّص المستلم ما سمعه بكلماته.

النتائج

تحسّن التسليم، وقلّت الأحداث الضارة المبلَّغ عنها

47%

انخفاضًا في الأحداث الضارة المرتبطة بالتسليم، كما أبلغ عنها الأطباء المقيمون أنفسهم.

66%

من التسليمات الشفهية تضمّنت العناصر الخمسة كلها، بعد أن كانت 20%.

83%

من التسليمات لخّص فيها المستلم ما سمعه، بعد أن كانت 31%.

Starmer et al., J Hosp Med, 2023

TAMAYUZ 10X

مراجعة منهجية · 2025

أيّ طريقة تسليم يدعمها الدليل أكثر؟

بحثت مراجعة منهجية في أدلة السنوات العشر الأخيرة عن 12 أداة للتسليم داخل أقسام المستشفى.

وجدت أن طريقة (I-PASS) تقلّل الأخطاء والأحداث الضارة بدرجة يقين متوسطة، استنادًا إلى عشر دراسات.

وأن أداة (SBAR) الأقدم قد تحسّن السلامة، لكن بدرجة يقين منخفضة.

وأن الأدوات الأخرى لم تُختبر بما يكفي للحكم عليها.

تُقال المعلومة المهمة في كل مرة، وبالترتيب نفسه

ثم يلخّص المستلم ما سمعه بكلماته، فيظهر سوء الفهم قبل أن ينصرف زميله.

فتعتمد سلامة المريض أقلّ على ذاكرة من يسلّم في نهاية يوم متعب.

هذا تفسير من الكاتب، لا نتيجة قاستها الدراسة.

ولا يكفي التوحيد دائمًا

قد يتحسّن التسليم ولا يتغيّر المؤشر الرئيس

41%

انخفاضًا في قرح الضغط في تجربة عشوائية بتسعة أجنحة أسترالية، لكن مؤشرها الرئيس لم يتغيّر.

3/16

من الدراسات التي قاست الأحداث الضارة وجدت تحسّنًا، في مراجعة جمعت 42 دراسة.

وكانت النتائج أفضل في الغالب حين اجتمع التدريب مع تغيير طريقة العمل نفسها.

مستخلص من الدراسات

ما الذي يستطيع القائد فعله؟

1

أن يختار طريقة تسليم مختبرة، ويطلب من المستلم أن يلخّص ما سمعه.

2

ألّا يكتفي بالتدريب، بل يغيّر طريقة العمل: نموذج موحّد، ووقت ومكان محددان، ومتابعة في الأشهر الأولى.

3

أن يقيس جودة التسليم بالملاحظة المباشرة، ويتابع النتائج مدة كافية.

> **أيّ تسليم بين فريقين في مؤسستك يعتمد اليوم على ذاكرة شخص واحد؟**

حدود هذه الأدلة

دراسة المستشفيات الاثنين والثلاثين بلا مجموعة مقارنة، وأحداثها الضارة أبلغ عنها الأطباء أنفسهم.

لبعض مؤلفيها حصص في شركة تدرّب على هذه الطريقة، وتولّى التحليل فريق مستقل.

لم تشمل الدراسات مستشفيات عربية، وتعميمها على قطاعات أخرى استنتاج.

تنويه تحريري: الآراء والتحليلات الواردة في هذا المقال تمثل رأي الكاتب وتحليله المهني استنادًا إلى المصادر المشار إليها، ولا تمثل بالضرورة المواقف الرسمية للجهات المذكورة. وللاطلاع على المعلومات والمراجع الأصلية والكاملة والأحدث، يُرجى الرجوع مباشرة إلى المصادر الأصلية والوثائق الرسمية الواردة في قائمة المراجع.

[1] Starmer, A. J., et al. (2023). Implementation of the I-PASS handoff program in diverse clinical environments. *Journal of Hospital Medicine*, 18(1), 5–14.

[2] McCarthy, S., et al. (2025). Use of structured handoff protocols for within-hospital unit transitions. *BMJ Quality & Safety*, 34(10), 680–690.

[3] Rihari-Thomas, J., et al. (2026). ACCELERATE: a stepped-wedge cluster randomised trial. *International Journal of Nursing Studies*, 183, 105652.

[4] Allen-Dicker, J., et al. (2025). Physician inpatient handoffs: a systematic review. *Journal of Hospital Medicine*, 20(6), 607–622.

المقال الكامل: tamayuz10x.com/article-oe-evidence-standardized-handoffs.html